

CAPÍTULO 10.20

Infecciones Oportunistas

PERFIL EUNACOM 1.05.1.020  
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Infecciones Oportunistas en VIH/SIDA

Comparativa Clínica y Diagnóstica

| TABLA 10.20.1: AGENTE VS CLÍNICA CARACTERÍSTICA |                                                                    |                                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AGENTE                                          | CLÍNICA CARACTERÍSTICA                                             | DIAGNÓSTICO                                                                 | TRATAMIENTO                                          |
| Candida (oral/genital)                          | Muguet (placas blancas), balanitis, leucorrea grumosa              | Clínico                                                                     | Fluconazol 150 mg PO 1 dosis                         |
| Candida esofágica                               | Disfagia + odinofagia                                              | Prueba terapéutica con fluconazol (si no mejora en 3 días → EDA)            | Fluconazol 200 mg 2 veces al día 21 días             |
| Pneumocystis jirovecii (PCP)                    | Neumonía subaguda (semanas) bilateral, LDH muy elevada             | PCR o Inmunofluorescencia directa                                           | Cotrimoxazol (+ corticoides si PO <sub>2</sub> < 70) |
| Toxoplasma gondii                               | Absceso cerebral: signos focales, convulsiones                     | TAC con contraste → lesión con realce en anillo                             | Sulfadiazina + Pirimetamina                          |
| Cryptococcus                                    | Meningitis (menínea: rigidez de nuca, Kernig, Brudzinski)          | PL → LCR con tinta china: levaduras capsuladas + glucosa baja + mononuclear | Anfotericina B liposomal                             |
| CMV                                             | Coriorretinitis (↓ agudeza visual) ± colitis, esofagitis, adenitis | Fondo de ojo                                                                | Ganciclovir / Valganciclovir                         |
| MAC (M. avium complex)                          | Sepsis subaguda/crónica, baja de peso, fiebre sin foco claro       | PCR para micobacterias atípicas                                             | Claritromicina / Etambutol / Rifabutin               |
| Criptosporidium                                 | Diarrea acuosa crónica                                             | Parasitológico especial                                                     | Solo TARV (si ATR eficaz)                            |
| Isospora                                        | Diarrea acuosa crónica                                             | Parasitológico especial                                                     | Cotrimoxazol                                         |
| Microsporidium                                  | Diarrea acuosa crónica                                             | Parasitológico especial                                                     | Albendazol                                           |
| Sarcoma de Kaposi                               | Nódulos violáceos/eritematosos en piel                             | Biopsia (para diferenciar de Angiomatosis Bacilar = Bartonella)             | TARV + Quimio/Radio/Cirugía                          |
| LMP (Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva)  | Signos focales + demencia progresiva                               | RMN cerebro: lesiones desmielinizantes múltiples en sustancia blanca        | Solo TARV (no hay tratamiento específico para VJC)   |

**EUNACOM CRITERIOS**

**Reglas de oro VIH:** - PCP → LDH elevada + neumonía bilateral subaguda - Toxoplasma → Lesión cerebral en anillo en TAC - Criptococo → Meningitis en VIH - CMV → ↓ visión en VIH - MAC → Sepsis insidiosa con CD4 < 50 - Criptosporidiosis vs Criptococosis

No confundir (parásito intestinal vs hongo meníngeo)

**Familia Herpesviridae (Resumen)**

| NÚMERO  | NOMBRE           | ENFERMEDAD                             |
|---------|------------------|----------------------------------------|
| HHV-1   | Herpes simplex 1 | Herpes bucal, encefalitis herpética    |
| HHV-2   | Herpes simplex 2 | Herpes genital                         |
| HHV-3   | VVZ              | Varicela + Herpes zóster               |
| HHV-4   | VEB              | Mononucleosis                          |
| HHV-5   | CMV              | Coriorretinitis (VIH), TORCH           |
| HHV-6/7 | —                | Exantema súbito (roseóla) en lactantes |

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**

**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente VIH positivo con CD4 de 150/mm<sup>3</sup> consulta por disfagia de 2 semanas de evolución. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Infecciones Oportunistas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- **Candidiasis esofágica:** disfagia en VIH, fluconazol 21 días. Primero prueba terapéutica, endoscopia solo si no mejora en 3 días.
- **Pneumocystis jirovecii:** más frecuente definitiva de SIDA. Neumonía arrastrada bilateral, LDH alta, infiltrado intersticial difuso. PCR o inmunofluorescencia. Cotrimoxazol + corticoides si PaO<sub>2</sub><70.
- **Toxoplasma:** signos focales + convulsiones en VIH. TAC: captación en anillo. Sulfadiazina + pirimetamina.
- **Criptococo:** meningoencefalitis con signos meníngeos. Tinta china en LCR (levadura capsulada). Anfotericina liposomal.
- **CMV:** coriorretinitis (baja agudeza visual, fondo de ojo), colitis, adenitis. Ganciclovir/foscarnet.
- **No confundir:** criptococo (meningitis) vs criptosporidium (diarrea). Sarcoma de Kaposi (herpes 8) vs angiomatosis bacilar (Bartonella) = biopsia.
- **Neumonía más frecuente en VIH:** neumococo (no Pneumocystis). Causa más frecuente de convulsiones en VIH: toxoplasma.
- **Leucoomalacia multifocal (virus JC):** demencia + lesiones sustancia blanca en RMN. Solo tratamiento con triterapia.

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFECCIONES OPORTUNISTAS)

## PREGUNTA 1

Paciente VIH positivo con CD4 de 150/mm<sup>3</sup> consulta por disfagia de 2 semanas de evolución. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ A) Endoscopia digestiva alta inmediata
- ☐ B) Iniciar fluconazol por 21 días como prueba terapéutica
- ☐ C) Solicitar cultivo faríngeo para Candida
- ☐ D) Iniciar ganciclovir por sospecha de esofagitis por CMV
- ☐ E) Aciclovir oral por sospecha de esofagitis herpética

## PREGUNTA 2

Hombre de 32 años con baja de peso de un año y promiscuidad sexual presenta neumonía bilateral de 3 semanas de evolución, con infiltrado intersticial difuso en radiografía y LDH de 850 U/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- ☐ A) Neumonía por neumococo; ceftriaxona
- ☐ B) Neumonía por Pneumocystis jirovecii; cotrimoxazol
- ☐ C) Tuberculosis pulmonar; esquema RIPE
- ☐ D) Neumonía por Mycoplasma; azitromicina
- ☐ E) Neumonía por CMV; ganciclovir

## PREGUNTA 3

Paciente VIH con CD4 de 60/mm<sup>3</sup> presenta hemiparesia derecha y convulsión tónico-clónica focal. El TAC con contraste muestra lesión frontal izquierda que capta contraste en anillo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Meningoencefalitis por criptococo
- ☐ B) Leucomalacia multifocal progresiva
- ☐ C) Toxoplasmosis cerebral
- ☐ D) Neumonía por Pneumocystis con compromiso neurológico
- ☐ E) Linfoma primario del SNC

## RESUMEN: INFECCIONES OPORTUNISTAS

Esta clase revisa las infecciones oportunistas del VIH. La candidiasis oral (algorra) y genital son etapa B; la candidiasis esofágica es definitiva de SIDA (etapa C), se presenta con disfagia, se trata con fluconazol 21 días y ante sospecha se hace prueba terapéutica antes de endoscopia. Pneumocystis jirovecii es la infección definitiva de SIDA más frecuente. Produce neumonía bilateral de curso arrastrado (semanas), con LDH muy elevada e infiltrado intersticial bilateral difuso en radiografía. Diagnóstico con PCR o inmunofluorescencia directa. Tratamiento con cotrimoxazol; agregar corticoides si PaO<sub>2</sub> <70 mmHg. Toxoplasma gondii (segunda más frecuente) produce encefalitis focal con signos focales, convulsiones parciales. TAC con contraste muestra lesión que capta en anillo. Tratamiento con sulfadiazina + pirimetamina. Cryptococcus produce meningoencefalitis (signos meníngeos, rigidez de nuca). Diagnóstico con punción lumbar y tinción con tinta china (levadura capsulada). Tratamiento con anfotericina liposomal. Citomegalovirus produce coriorretinitis (disminución de agudeza visual, diagnóstico con fondo de ojo), colitis, adenitis. Tratamiento con ganciclovir o foscarnet. Mycobacterium avium complex produce sepsis subaguda insidiosa, diagnóstico con PCR. Criptosporidium, isospora y microsporidium producen diarrea crónica acuosa. Sarcoma de Kaposi (virus herpes 8) produce nódulos eritematovioláceos, diagnóstico con biopsia (diferenciar de angiomatosis bacilar). Leucomalacia multifocal progresiva (virus JC) produce signos focales y demencia, lesiones de sustancia blanca en RMN, solo tratamiento con triterapia.